

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5063509-05.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE
RECORRENTE: DAVI DANIEL MARTINS VIEIRA
RECORRENTE: VITORIA MARTINS DA SILVA
RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

AGRAVO/MEDIDA DE URGÊNCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DIREITO A SAÚDE. TRATAMETO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. URGÊNCIA DEMONSTRADA. TUTELA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO DO JUÍZO A QUO REFORMADA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER dos recurso e DAR-LHE provimento para, na forma do art. 300 do CPC, para para determinar que os réus, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, forneçam à parte autora o fármaco infantil à base de proteína hidrolisada, nos termos da prescrição médica juntada em Evento 1, ANEXO2, pág.16. Dirciono à UNIÃO o cumprimento da referida obrigação, por se tratar de medicamento não padronizado pelo SUS no âmbito do SMS/RJ, resguardada a possibilidade de ressarcimento em desfavor dos demais entes réus, ante a responsabilidade solidária das entidades federativas no presente caso. Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 11 de setembro de 2024.

5063509-05.2024.4.02.5101510014207344 .V4

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5063509-05.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE
RECORRENTE: DAVI DANIEL MARTINS VIEIRA
RECORRENTE: VITORIA MARTINS DA SILVA
RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência, interposta pela parte autora, em face da decisão do Evento 5 dos autos originários, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada, que objetiva o fornecimento de **FÓRMULA LÁCTEA INFANTIL À BASE DE AMINOÁCIDOS LIVRES (NEOCATE)**, nos termos dos laudos anexados.

Aduz que o recorrente, com apenas 4 meses de vida incompletos, foi diagnosticado com quadro de alergia à proteína do leite de vaca. Por consequência, apresenta diarreias, fissuras anais, sangramento nas fezes, e sofre com dores ao evacuar. Por ser lactante, depende do fornecimento de Fórmula Láctea Infantil à base de Aminoácidos Livres, pelo tempo que se fizer necessário. Uma nutrição que atenda às necessidades é condição fundamental para que a criança possa atingir seu pleno desenvolvimento.

Tutela deferida em decisão desta relatora no evento 8.

Contrarrzões apresentadas em evento 18

Passo a decidir.

DA SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. RESPONSABILIDADE DA UNIÃO FEDERAL

O art. 196, da CF/88, norma de aplicabilidade plena, declara o direito à saúde: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Assim, ainda que as ações e serviços públicos de saúde sejam informados pela descentralização, conforme a norma constitucional inscrita no art. 198, I, da CRFB (e repetida no art. 7º, IX, da Lei n.º 8.080/1990), certo é que a própria Carta Magna estabelece uma competência concorrente (art. 24, XII) entre os entes constitutivos da federação para legislar sobre o assunto, bem como a competência material comum aos mesmos para realizar as ações correspondentes.

Tanto assim que a Lei n.º 8.080/1990 discrimina as competências da União Federal em seu artigo 16. Acrescente-se que, no que toca ao financiamento dos serviços de saúde, a União Federal tem participação direta, ainda que os serviços sejam prestados prioritariamente pelos Estados e Municípios.

A Portaria nº 3.916/MS/GM, de 30 de outubro de 1998 prevê a RENAME - Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, de responsabilidade do Ministério da Saúde e prevê, igualmente a gestão do SUS pelos três níveis de governo, de modo a se promover um fornecimento de remédios racionalizado, padronizado e eficiente.

Desse modo, não é possível o argumento de que a Constituição ou mesmo sua lei integradora tenham querido limitar o acesso à rede pública de saúde ou às ações de saúde. A melhor interpretação é justamente a contrária. Deve ser amplo o atendimento, independentemente da correspondência federativa da entidade pública procurada ou das atribuições administrativas de cada ente político.

Assim, a divisão de responsabilidades entre União, Estado e Município não pode vincular a atuação do SUS frente ao administrado, que depende do Poder Público para garantir o seu direito à saúde.

Por outro lado, a solidariedade no campo assistencial do SUS sempre proporcionará ao ente obrigado judicialmente ao desembolso de valores, a possibilidade de ressarcimento ou compensação administrativa junto aos demais. As ações do SUS dependem de uma atuação coordenada dos entes públicos envolvidos na sua organização.

No que toca ao fornecimento de remédios, a União Federal tem responsabilidade sobre o Financiamento da Assistência farmacêutica Básica, nos termos da Portaria nº 2.084/GM de 26 de outubro de 2005, repassando para os Estados e Municípios a verba para a compra dos medicamentos para Atenção Básica. Logo, a União tem competência não só para traçar regras gerais a serem cumpridas no SUS, como também para promover, quando necessário, a devida assistência in concreto. Os mecanismos de compensação dos entes que atuam no SUS - União, Estados e Municípios - não podem impedir a prestação positiva do Estado.

No mesmo sentido, dispõe o Enunciado 43 das Turmas Recursais do Rio de Janeiro:

Enunciado 43: “A União é parte legítima nas demandas que visem assegurar o direito às prestações do Sistema Único de Saúde - SUS.”

Neste sentido, confira-se recente jurisprudência do STF, que ratifica seu posicionamento acerca da solidariedade dos entes públicos no fornecimento de medicamentos, nos seguintes termos:

DECISÃO: Vistos. União interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Estado do Espírito Santo, que manteve a decisão do juízo monocrático, que indeferiu o chamamento da União para integrar o polo passivo de demanda em que se discute fornecimento de medicamentos. Opostos embargos de declaração (fls. 219/220), foram rejeitados (fls. 223/224). Alega o recorrente violação dos artigos 37, caput, e 198, inciso I, da Constituição Federal. Contra-arrazoado (fls. 241 a 247), o recurso extraordinário (fls. 229 a 230) foi admitido (fl. 249). Decido. Anote-se, inicialmente, que o recurso extraordinário foi interposto contra acórdão publicado após 3/5/07, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional objeto do recurso, conforme decidido na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento nº 664.567/RS, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/07. Todavia, apesar da petição recursal haver trazido a preliminar sobre o tema, não é de se proceder ao exame de sua existência, uma vez que, nos termos do artigo 323 do

Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com a redação introduzida pela Emenda Regimental nº 21/07, primeira parte, o procedimento acerca da existência da repercussão geral somente ocorrerá “quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão”. Não merece prosperar a irresignação. Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia sobre legitimidade passiva da União em ação em que se discute a obrigação de fornecer medicamentos, em harmonia com a jurisprudência desta Corte que, no julgamento do RE nº 808.059/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski (DJe de 1º/2/11), fixou entendimento no sentido de que a obrigação dos entes da federação no que tange ao dever fundamental de prestação de saúde é solidária. Nesse sentido, também, as recentes decisões monocráticas: AI nº 817.241/RS, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 14/10/10; RE nº 839.594/MG, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 3/3/11, e AI nº 732.582/SP, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 17/3/11. Sobre o tema, ainda, anote-se o seguinte precedente: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE (ART. 196, CF). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SOLIDARIEDADE PASSIVA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESLOCAMENTO DO FEITO PARA JUSTIÇA FEDERAL. **MEDIDA** PROTETÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O artigo 196 da CF impõe o dever estatal de implementação das políticas públicas, no sentido de conferir efetividade ao acesso da população à redução dos riscos de doenças e às medidas necessárias para proteção e recuperação dos cidadãos. 2. O Estado deve criar meios para prover serviços médico-hospitalares e fornecimento de medicamentos, além da implementação de políticas públicas preventivas, mercê de os entes federativos garantirem recursos em seus orçamentos para implementação das mesmas. (arts. 23, II, e 198, § 1º, da CF). 3. O recebimento de medicamentos pelo Estado é direito fundamental, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos, desde que demonstrada sua necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios. Isto por que, uma vez satisfeitos tais requisitos, o ente federativo deve se pautar no espírito de solidariedade para conferir efetividade ao direito garantido pela Constituição, e não criar entraves jurídicos para postergar a devida prestação jurisdicional. 4. In casu, o chamamento ao processo da União pelo Estado de Santa Catarina revela-se **medida** meramente protetória que não traz nenhuma utilidade ao processo, além de atrasar a resolução do feito, revelando-se meio inconstitucional para evitar o acesso aos remédios necessários para o restabelecimento da saúde da recorrida. 5. Agravo regimental no recurso extraordinário desprovido” (RE nº 607.381/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 17/6/11) Diga-se, por fim, que nos autos do RE nº 566.471, Relator o Ministro Marco Aurélio, discute-se a possibilidade de condenação de Estados ou municípios ao custeio de medicamentos que não integram a lista daqueles fornecidos gratuitamente pelo sistema de saúde pública. Essa matéria, portanto, não se confunde

Seção:

No mesmo sentido, o STJ, recentemente, pacificou seu entendimento na Primeira

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DE TODOS OS ENTES FEDERADOS. PRECEDENTES DA PRIMEIRA SEÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL DECLARADA PELO STF. SOBRESTAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção firmaram o entendimento de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios.

Dessa forma, qualquer um destes Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda.

2. A repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, nos termos do art. 543-B do CPC, não enseja o sobrestamento dos Recursos Especiais que tramitam neste Superior Tribunal de Justiça, mas de eventual Recurso Extraordinário a ser interposto. Precedentes: AgRg no AgRg no AREsp 110.184/CE, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJe 30/10/12 e AgRg no REsp. 1.267.702/SC, Quinta Turma, Rel.

Min. JORGE MUSSI, DJe 26/9/11, AgRg no REsp. 1.334.109/SC, Rel. Min.

SÉRGIO KUKINA, DJe 25.06.2013.

3. Agravo Regimental do Município de Belo Horizonte desprovido.

(AgRg no AREsp 325.781/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 10/03/2014)

com a do presente recurso extraordinário, que trata do chamamento da União ao processo e da eventual responsabilidade solidária dos entes da Federação. Ante o exposto, nos termos do artigo 557, caput, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se (STF, Primeira Turma, Relator Ministro Dias Toffoli, RE 668603 / ES, data da julgamento: 26/04/2013).

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE SAÚDE

As atribuições relativas à assistência farmacêutica no campo da saúde pública, englobam as atividades de seleção, programação, aquisição, armazenamento e distribuição, controle da qualidade e utilização – compreendidas a prescrição e a dispensação – de medicamentos (artigos 16, X; 17, VIII; e 18, V, da Lei n. 8.080/1990 e item 3.3 da Portaria MS n. 3.916, de 30 de outubro de 1998 – Política Nacional de Medicamentos). O Decreto nº 7.508/11 recentemente deu nova regulamentação à Lei 8.080/80, não alterando a linha da descentralização.

Em toda hierarquização e descentralização quanto ao fornecimento direto de medicamentos e demais insumos respectivos, fica claro que: (i) cabem ao gestor municipal as responsabilidades para definição dos medicamentos essenciais e para o seu abastecimento. Ou seja, os medicamentos fornecidos pelo município são aqueles considerados básicos e

indispensáveis para atender a maioria dos problemas de saúde da população; (ii) compete aos Estados federados a dispensação de medicamentos de ordem excepcional, ou seja, medicamentos utilizados em doenças raras, geralmente de custo elevado, cuja compra e disponibilização atende a casos específicos; (iii) por fim, quanto à União Federal, é conferida pela Política Nacional de Medicamentos a responsabilidade em adquirir e distribuir produtos em situações especiais considerando três pressupostos básicos, de ordem epidemiológica, a saber: a) doenças que configuram problemas de saúde pública, que atingem ou põem em risco a coletividade, e cuja estratégia de controle concentra-se no tratamento de seus portadores; b) doenças consideradas de caráter individual que, a despeito de atingir número reduzido de pessoas, requerem tratamento longo ou até permanente, com o uso de medicamentos de custos elevados; c) doenças cujo tratamento envolve o uso de medicamentos não disponíveis no mercado.

Portanto, a conclusão a que se chega é que a competência da União no fornecimento de medicamentos, conforme farta regulamentação, se refere aos: a) medicamentos de interesse em saúde pública: aqueles utilizados no controle de doenças que, em determinada comunidade, têm magnitude, transcendência ou vulnerabilidade relevante e cuja estratégia básica de combate é o tratamento dos doentes; e b) medicamentos de uso contínuo: são aqueles empregados no tratamento de doenças crônicas e ou degenerativas, utilizados continuamente, sendo que em ambos os casos, só serão fornecidos pela União aqueles que se encaixarem no perfil estratégico concernente à definição de sua esfera de responsabilidade. Com base nessa divisão de responsabilidades, delimita-se a competência da Justiça Federal e consequentemente dos Juizados Especiais Federais para apreciar as ações que objetivam o fornecimento de medicamentos, atendo-se somente àquelas em que a dispensação de medicamentos caiba à União Federal.

Na mesma linha da argumentação acima, segue parte da jurisprudência do STJ e também a jurisprudência pacífica do TRF da 2ª Região, conforme, com grifos nossos:

“SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. EXECUÇÃO DIRETA DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO FEDERAL.

I - A Primeira Turma deste Superior Tribunal de Justiça vem decidindo pela ilegitimidade da União para figurar em ação para fornecimento gratuito de medicamentos.

II - A competência da União está adstrita à gestão federal do SUS, repassando os recursos financeiros, cabendo então aos Municípios e, supletivamente, aos Estados, a aquisição e a adequada dispensação de medicamentos. Precedente: (AgRg no REsp nº 888.975/RS, Relator p/ Acórdão Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ de 22.10.2007).

III - Agravo regimental provido. (STJ - AgRg no Ag 879.975/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, Rel. p/ Acórdão Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, DJe 14/04/2008)

*“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. UNIÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. A sentença, também condicionada a reexame necessário, ratificando a decisão antecipatória, condenou somente a União a fornecer ao autor, portador de esquizofrenia psicótica, os medicamentos Losartana Potássica 100mg/dia; Pimozida 04 mg/dia; Flurazepan 30 mg/dia, e Dicloridrato de Manidipin, disponibilizando quantidade suficiente para o tratamento no período de 180 (cento e oitenta) dias, de acordo com a necessidade diária prescrita nos laudos médicos..., nas quantidades mensais especificadas com base nos receituários..., devendo o Autor apresentar, a cada 06 (seis) meses, receituário atualizado, comprovando a necessidade de uso continuado dos referidos medicamentos. 2. A União Federal, em regra, no âmbito do SUS, não tem atribuição de distribuir diretamente medicamentos, do que decorre a sua ilegitimidade passiva para responder ações movidas para obtê-los. Inteligência da Lei nº 8.080/90. Precedentes da Turma. 3. A remessa dos autos à Justiça Estadual, melhor ajustada à sistemática do SUS, tem o efeito prático de aproximar os pacientes necessitados de assistência médico-farmacêutica dos organismos locais responsáveis, assim otimizando a efetividade das prestações demandadas. 4. Na hipótese, a parte autora, portadora de esquizofrenia psicótica, necessita de remédios não integrantes da lista de medicamentos excepcionalmente fornecidos pela União Federal, e dos autos não consta laudo médico categórico afirmativo da essencialidade dos medicamentos em causa, destacando-os como únicos e insubstituíveis para restabelecer a saúde do paciente, e situando-o, nessa **medida**, em quadro excepcional para justificar tratamento diferenciado, de sorte que se impõe a remessa do feito ao Estado. 5. Apelação da União Federal e Remessa Necessária providas. Apelação da parte autora e agravo retido prejudicados.”*

(TRF2, APELRE 200951010132455, Desembargadora Federal NIZETE LOBATO CARMO, SEXTA TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R 22/01/2013.)

“AGRAVOS INTERNOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. EXCLUSÃO DA UNIÃO DO PÓLO PASSIVO. 1. Agravos internos contra a decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento e determinou a exclusão da União do pólo passivo da demanda na qual se pede a entrega de medicamentos, com a remessa dos autos ao Juízo estadual competente. 2. A asseveração de solidariedade apenas significa que os entes federativos dos três níveis têm o dever de compor o sistema de saúde pública, na forma delineada pela Constituição Federal e especificada pela legislação infraconstitucional. Assim, ela é insuficiente para fazer com que se possa litigar ou não contra a União Federal, em casos nos quais não existe, na distribuição interna das competências, dever da União de comprar ou fornecer o remédio específico. 3. Agravos internos não providos.” (TRF2, AG 201202010183666, Desembargador Federal GUILHERME COUTO, SEXTA TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R 17/12/2012.)

ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ILEGITIMIDADE DA UNIÃO FEDERAL. REMESSA À JUSTIÇA DO ESTADO.

Em regra, não é pertinente a inserção da UNIÃO FEDERAL no pólo passivo de pleito em que se

objetiva obter remédios. A atuação da União Federal, no âmbito do problema relativo a medicamentos, não é a de comprá-los e de distribuí-los, diretamente. O Sistema Único de Saúde objetiva coordenar os recursos e práticas ligadas à saúde pública, de modo a dividir atribuições e obter eficiência. Não cabe à União a compra e a entrega direta de medicamentos, salvo os casos especiais previstos na divisão de atribuições. Assim, exclui-se da lide a União Federal e, com fulcro no artigo 113 do CPC, pronuncia-se a nulidade da sentença, determinada a remessa dos autos à Justiça do Estado, para que lá tudo seja apreciado. Remessa (conhecida de ofício) e apelação da UNIÃO FEDERAL providas. Prejudicado o apelo do Estado do Rio de Janeiro.(TRF2 - AG 201202010107937, Rel. p/acórdão GUILHERME COUTO, E-DJF2R - Data::26/09/2012.)

“PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

1. Conquanto a apreciação do agravo retido interposto pela União não tenha sido requerida em sua apelação (art. 523, § 1º, do CPC), o recurso poderia ser conhecido por força da remessa necessária. Todavia, não o será porquanto se insurge contra o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela e porque a ilegitimidade passiva suscitada é reiterada nas razões de apelação.

2. A aquisição e distribuição dos medicamentos para combater a doença que acomete a autora (glaucoma) inserem-se entre as atribuições do Estado e do Município (art. 9º, §1º, inciso II, da Portaria nº 288/ SAS, de 19 de maio de 2008). Desprezar a repartição de atribuições, prevista na Lei nº 8.080/90 (artigos 16 a 19) e demais normas que regulamentam o funcionamento do SUS, torna o sistema ineficiente e dispendioso, notadamente em vista de condenações solidárias dos entes ao fornecimento dos mais variados medicamentos. A União não tem a incumbência de adquiri-los e distribuí-los, pois os medicamentos pleiteados não estão listados na Portaria nº 2.981/2009. Reconhecida a ilegitimidade da União e, portanto, a incompetência da Justiça Federal, deve ser declarada a nulidade da sentença e encaminhado o processo à Justiça Estadual (art. 113, § 2º, do CPC).

3. Agravo retido da União não conhecido e remessa e apelação da União providas. Prejudicados os recursos dos demais réus.” (grifou-se e destacou-se).

(TRF2, AC 200851010252432, Desembargador Federal LUIZ PAULO DA SILVA ARAÚJO FILHO, SÉTIMA TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R 08/03/2013)

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS NÃO PADRONIZADOS

Após longo debate, a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.657.156/RJ entendeu que é de obrigação do poder público fornecer medicamentos que estão fora da lista do Sistema Único de Saúde (SUS), desde que os satisfeitos todos os requisitos, conforme o entendimento a seguir:

“EMENTA ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO.

1. Caso dos autos: (...) 2. Alegações da recorrente:(...) 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas. 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015.” STJ - Resp: 1657156 RJ 2017/0025629-7, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 25/04/2018, S1, PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: Dje 04/05/2018(grifos e abreviações nossas).

Após análise dos autos, resta claro que a parte autora satisfaz os requisitos necessários para a concessão de medicamentos.

Acerca do primeiro requisito, verifico que a parte autora juntou laudo médico, expedido por médica que assiste o menor, que demonstrou a necessidade do uso da fórmula infantil à base de proteína hidrolisada (NEOCATE) para recuperação e manutenção de um bom estado nutricional:



Encaminhamento da Atenção Secundária para a Atenção Primária
Solicitação de Consulta

Dados do Paciente

Nome*	Dani Daniel montes vicina							CPF*	
Data de Nascimento*	Idade	Sexo*	Raça/cor*	Peso(kg)	Altura(m)	Pressão arterial(mmHg)	Temperatura		
28/04/2024	3m	M	Branca	54,9	1,02		36,0		
Nome da Mãe*	Victoria Montes da Silva								
Endereço*	Travessa Lavoura n.º 03			Bairro*			Higienópolis		
Município/Estado Residência*	RJ			Município/Estado de Nascimento*			RJ		
Unidade de Saúde Solicitante (Unidade de Atenção Secundária)*	17777777			CNEC*			980537503		
Telefone da Unidade			22540272						

Dados da Unidade de Atenção Primária

Unidade de Atenção Primária encaminhada*	AP*	Endereço da Unidade
Motivo do Encaminhamento*		
Leituras de 3m de vida com fôlego com parque + fôlego anormal + diarreia anormal 3 dias de vida; marcar Contato - Pediatra pelo SUS RJ		
Resultado de Exames Complementares		
G. F. F. F. F.		
CID 10	Data do Encaminhamento*	
	07/08/24	

* campos obrigatórios

Nome e Carimbo do Profissional

Orientações:

- 1) Esta requisição é padronizada para as Unidades de Atenção Secundária encaminharem algum paciente para a Atenção Primária;
- 2) Após preenchimento dos dados o paciente deve ser encaminhado para a sua Unidade de Atenção Primária, portando esta solicitação. A unidade requisitante deve informar o endereço (pode ser consultado em www.rio.rj.gov.br/secretaria-saude) e preencher com o máximo de informações possíveis relevantes;
- 3) Em caso de motivo de solicitação de nova consulta especializada, caberá à Unidade de Atenção Primária (ou seja, no médico responsável pelo paciente) a coordenação do cuidado, segundo o SUS RJ a solicitação da consulta especializada, quando for necessário, e comunicar o paciente quando do agendamento da consulta especializada;
- 4) A Unidade de Atenção Secundária deve solicitar nova consulta especializada no SUS RJ, mas sem encaminhar à Atenção Primária para avaliação do caso;
- 5) A Unidade de Atenção Secundária deve solicitar ao SUS RJ a realização das consultas especializadas de forma prioritária;
- 6) A descentralização para as unidades de Atenção Primária torna mais rápido e eficiente o atendimento;

P. de Solicitação SUS RJ. Contato com "a mancha"
e de outro lado do mesmo bloco de avaliação

IASERJ Secretaria de Saúde RIO DE JANEIRO SUS Cão 1000	
Formulário: RECEITUÁRIO	
Unidade de Saúde: <u>Bo Joséy Maracaná</u>	
<u>Do Hm m Jus</u>	
Solicitado avaliação pelo setor Gastroenterologia	
Infante do nome Dani Daniel Montes	
da filha DN: 28/4/2024	
Hábitos maternos: intolerância alimentar	
Dani fez episódios diários / fezes penhas	
solitas / diarreia abdominal, tratado com	
um UPA de vom (no para vom / Aptauil	
Joy, evoluindo com constipação e fezes	
tombado resacas (Adeitado), alternativa	
Aptauil pipet (4x 100, mas diários e fezes	
Sanguinolentas), retornou ao Aptauil Joy com	
melhora parcial sintomas (ando fezes	
episódios + episódios diários)	
Solicitado avaliação Gata	
ADU?	

Gratiana Cavallaro
Pediatra ROE 50831
CRM 52.82439-0

02/2/24



Quanto ao terceiro requisito, o PARECER TÉCNICO CRLS Nº 106925/2024 (Evento 1, ANEXO2, págs. 19/22) informou que a SMS possui o Programa de Assistência à Criança Portadora de Diarreia Persistente (PRODIAPE), criado em junho/1996 no Hospital Municipal Jesus, com o objetivo de proporcionar o tratamento ambulatorial para diarréia persistente.

Além disso, informou que NEOCATE®, insumo pleiteado, não faz parte de nenhuma lista oficial de dispensação do SUS, não sendo dispensado a nível ambulatorial ou domiciliar.



CÂMARA DE RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS EM SAÚDE

Parecer Técnico CRLS Nº 106925/2024

Rio de Janeiro, 14 de August de 2024

Prezados(a),

O presente parecer visa informar a Defensoria o encaminhamento realizado acerca do(s) produto(s) pleiteado(s) pelo assistido DAVI DANIEL MARTINS VIEIRA, os quais foi /foram analisado(s) pela(s) equipe(s) técnica(s) da SES e/ou SMS, resultando no seguinte encaminhamento/ parecer técnico:

PRODUTO	ENCAMINHAMENTO
Fórmula infantil à base de aminoácidos livres (NEOCATE®; AMINOMED®; PURAMINO®; ALFAMINO®) (Cod.:8073)	Defensoria

Cabe esclarecer que:

1 - O(s) produto(s) com encaminhamento para a Defensoria não se encontra(m) padronizado(s) em nenhuma lista oficial de medicamentos para dispensação através do SUS, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro.

Parecer Técnico Defensoria:

PRODUTO	PARECER
Fórmula infantil à base de aminoácidos livres (NEOCATE®; AMINOMED®; PURAMINO®; ALFAMINO®) (Cod.:8073)	Prezados, o presente parecer, elaborado pela equipe técnica da CRLS, objetiva informar a Defensoria Pública e Unidade(s) de Saúde assistentes acerca do encaminhamento do(s) produto(s) pleiteado(s) pelo(a) assistido(a) DAVI DANIEL MARTINS VIEIRA, 03 meses de idade, CNS: 702500782907640. Endereço: Travessa Juruna, 03, Higienópolis, Rio De Janeiro, RJ, 21.050-428, BRA _ Telefone: (21)9805-37503. Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência: CF BARBARA STARFIELD AP 32. PRODUTO(S) PLEITEADO(S): Fórmula infantil à base de aminoácidos livres (NEOCATE®) DOCUMENTO(S) ANALISADOS Para elaboração deste parecer técnico foi ou foram considerado(s) o(s) documento(s): Receita médica emitida no pelo IASERJ _ INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO na data de 12/07/2024. Encaminhamento médico emitido no pelo IASERJ _ INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO RIO DE

CÂMARA DE RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS EM SAÚDE

JANEIRO na data de 12/07/2024.

DAS CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS:

Encaminhamento médico emitido no pelo IASERJ informa que o lactante com 03 meses de idade fazendo fezes com sangue, fissura perianal, diarreia, vômito e distensão abdominal e que em UPA teve troca de Nan para Nan Soy ou Aptamil Soy evoluindo com constipação e fissura. Teve orientação para usar o NEOCATE, mas de grande valor monetário, como alternativa tentou o Aptamil Pepti, fez uso, mas continuou com diarreia e fezes sanguinolentas) retornou ao Aptamil Soy obteve melhora parcial.

Lactante com 03 meses de idade fazendo fezes com sangue, fissura perianal, diarreia, vômito e distensão abdominal.

Esclarecemos que, O PRODIAPE- Programa de Assistência à Criança Portadora de Diarreia Persistente e Alergia Alimentar, em funcionamento no Hospital Municipal Jesus desde 1996, destina-se ao atendimento e acompanhamento pela Gastroenterologia Pediátrica do hospital, de crianças residentes no município do Rio de Janeiro, portadoras ou com suspeita de alergia alimentar, má absorção ou diarreias crônicas a esclarecer. Destina-se a crianças que devido à tenra idade tem nas fórmulas infantis a sua principal fonte de alimento, o que normalmente encerra-se aos 24 meses de idade de modo que são raríssimos os casos de maiores dessa idade ainda assistidos pelo programa.

O atendimento era realizado via SISREG em CONSULTA EM PEDIATRIA LEITES ESPECIAIS, na Unidade Hospitalar de referência, HMJ, a fim de definir a pertinência na inserção do PRODIAPE.

Fomos comunicados pelo NIR da CAP que a oferta do procedimento CONSULTA EM PEDIATRIA LEITES ESPECIAS no HMJ foi encerrada no SISREG não havendo mais vagas disponíveis para o PRODIAPE.

O HMJ mantém o recurso de CONSULTA EM GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICA para diagnostico e acompanhamento de Crianças portadoras de Alergia Alimentar ou suspeita de Alergia Alimentar ou Má Absorção ou outras diarreias crônicas a esclarecer.

CÂMARA DE RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS EM SAÚDE

Em consulta ao SISREG identificamos:

Solicitação: 551205844 para CONSULTA EM GASTROENTEROLOGIA - PEDIATRIA inserida em 07/08/2024 na CF BARBARA STARFIELD AP 32 com a Classificação de Risco AMARELO – Urgência com o Status de APROVADO para: UFRJ IPPMG INST DE PUER PED MARTAGAO GESTEIRA na data de 30/10/2024 (QUA) às 07h00min.

SEGUNDO O FABRICANTE DANONE NEOCATE® LCP®, é uma fórmula infantil elementar para lactentes e de seguimento para lactentes e crianças de primeira infância para necessidades dietoterápicas específicas, possui fórmula nutricionalmente completa e isenta de proteína láctea, lactose, sacarose, frutose, galactose e ingredientes de origem animal. Contém aminoácidos livres e sintéticos, xarope de glicose, óleos vegetais e TCM. Adicionada de LCPufas (ARA e DHA) e nucleotídeos. Indicações: Alergia alimentar (ao leite de vaca, à soja, a hidrolisados e a múltiplas proteínas). Faixa etária: Lactentes e crianças de primeira infância, até 36 meses de vida. 1 colher-medida rasa (4,6g de pó) para cada 30ml de água quente previamente fervida.

Deste modo, conforme prescrição a (o) assistida (o) faz uso de 120 ml de fórmula de aminoácidos 08 x ao dia.

O calculo para diluição padrão é de 1 medida para 30ml segundo informação do fabricante da fórmula infantil NEOCATE®, são necessários em média para reconstituição 4,6g de pó para 30ml de água, deste modo para 120 ml seria necessário 4 medidas de NEOCATE® por tomada.

4 medida por 8 vezes ao dia será: 32 medidas ao dia. Ao mês será $32 \times 30 = 960$ medidas. Cada medida possui 4,6g vezes 960 medidas é igual 4.416 g.

A lata de NEOCATE® possui 400 g, logo $4.416g / 400g = 11$, desta forma será necessário um total de 4.416g /mês ou 11 latas de 400g/mês.

Informamos que NEOCATE®, não faz parte de nenhuma lista oficial de dispensação do SUS, não sendo dispensado a nível ambulatorial ou domiciliar.

ENCAMINHAMENTO:

CÂMARA DE RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS EM SAÚDE

À DEFENSORIA PÚBLICA:
Diante da falência dos recursos administrativos empenhados para a resolução extrajudicial, encaminha-se o caso à apreciação da Defensoria Pública.

Cordialmente,
Jaime Coutinho.

2 - O(s) produto(s) relacionado(s), com encaminhamento para a Unidade de Saúde, consta(m) nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde para retirada do(s) mesmo(s) assistidos está encaminhado para a(s).

PARECER	PRODUTO	RESPONSÁVEL - CARGO / EQUIPE
---------	---------	------------------------------

Assim, da análise dos elementos coligidos aos autos, constato que o laudo médico apresentado nos autos originários (Evento 1, ANEXO2), comprova que o demandante necessita do uso do fármaco requerido, de forma urgente, devido a sua idade precoce, que demanda maior risco de vida, certo de que a parte autora é pessoa hipossuficiente, não possuindo condições financeiras de suportar o tratamento recomendado para o seu mal, cabendo ao Estado providenciar o suporte necessário a tanto.

Nessa toada, verifico, a priori, a imprescindibilidade da medicação para o controle da grave enfermidade do menor, bem como o perigo de dano, considerando a natureza da doença e a idade do autor.

Como o vertente caso envolve medicamento não padronizado pelo SUS no âmbito do SMS/RJ, direciono, com base no Tema 793 do STF, o cumprimento da obrigação de fazer à União, resguardada a possibilidade de ressarcimento em desfavor dos demais entes réus, ante a responsabilidade solidária das entidades federativas no presente caso.

Impende rememorar que direito à saúde, além de se qualificar como direito fundamental que assiste a todas as pessoas, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida.

Por fim, destaca-se parecer do NATTJUS em evento 19:

III - CONCLUSÃO

1. *Cumpra informar que a base do tratamento da APLV é a exclusão das proteínas do leite de vaca da alimentação, com o objetivo de evitar o aparecimento dos sintomas, a progressão da doença e a piora das manifestações alérgicas*⁶.

2. *De acordo com o Ministério da Saúde, em crianças menores de seis meses que não estão em aleitamento exclusivo, recomenda-se*⁵: • Primeiramente, tentar reverter a alimentação da criança para a forma exclusivamente amamentada; mediante dieta materna de exclusão de leite e derivados;

Caso não seja possível retomar o aleitamento materno exclusivo, deve-se excluir qualquer fórmula com proteína do leite de vaca e substituir por fórmula infantil para lactentes destinada a necessidades dietoterápicas específicas;

- *Utilizar fórmula à base de proteína extensamente hidrolisada (FEH) como primeira opção. A depender da avaliação clínica, também é possível indicar fórmula à base de aminoácidos livres (FAA);*

- *A FAA é recomendada mediante critérios clínicos específicos, tais como: sintomas graves, como alto risco de reações anafiláticas, síndrome de má absorção grave com intenso comprometimento da condição nutricional, ou mediante a não remissão dos sintomas com a FEH.*

3. *Nesse contexto, em documento médico acostado (Evento 1, ANEXO2, Página 15) foi informado que houve tentativa de uso de fórmula extensamente hidrolisada (Aptamil pepti), mas apresentou diarreia e fezes sanguinolentas. Dessa forma, mediante a não remissão ou piora dos sinais e sintomas com a referida fórmula, recomenda-se utilizar fórmulas à base de aminoácidos livres (FAA)¹, portanto, ratifica-se a indicação de uso de FAA como a opção prescrita (Neocate LCP8), tendo em vista as tentativas de uso de fórmula extensamente hidrolisada (FEH) e outras fórmulas com melhora parcial dos sintomas, ratifica-se a indicação de uso de FAA pelo Autor.*

4. *Importante destacar que em lactentes com APLV em uso de FAA é recomendado que assim que possível haja tentativa de desencadeamento com FEH para avaliar a evolução da tolerância. Mediante estabilização com o uso de FEH, pode haver avaliação da tolerância com fórmula infantil tradicional (FI). Não sendo possível evoluir para FI, é indicado a permanência na FEH em média por mais 6 meses até nova testagem¹. Com isso, insta destacar que tal fórmula não é medicamento, e sim, opção substitutiva temporária de alimento alergênico, até que a criança desenvolva tolerância ao alérgeno. Dessa forma, sugere-se previsão do período de uso da FAA prescrita.*

5. *No tocante ao estado nutricional do Autor, seu dado antropométrico de peso mais recente (5.495g, em 07 de agosto de 2024, aos 3 meses de idade - Evento 1, ANEXO2, Página 1) foi avaliado segundo as curvas de crescimento para meninos da OMS, indicando que ele se encontrava com peso adequado para a idade ($\geq$ Escore -z -2 e < Escore -z -1) 7,8.*

6. *Cumpra informar que em lactentes do sexo masculino de 4 a 5 meses de idade, com estado nutricional adequado, estima-se que sejam necessárias em média 608 kcal/dia. Dessa forma, considerando opção comercial de FAA, estima-se que seja necessária uma oferta de 124,5g/dia, totalizando aproximadamente 10 latas de 400g/mês de fórmula de aminoácidos, e não as 11 latas/mês prescritas e pleiteadas 9,10.*

7. *Informa-se que em lactentes a partir dos 6 meses de idade é recomendado o início da introdução da alimentação complementar, com a introdução do almoço incluindo 1 alimento de cada grupo (cereais ou raízes e tubérculos, feijões, legumes e verduras, carnes e ovos e frutas), sendo recomendada a oferta de fórmula infantil 4 vezes ao dia (180-200ml, 4 vezes ao dia, totalizando ao máximo 800ml/dia). A partir do 7º mês de idade, deve ser introduzido o jantar, e o volume de fórmula reduz-se para 3 vezes ao dia (180-200ml, 3 vezes ao dia, totalizando ao máximo 600ml/dia) 11,12.*

8. *Destaca-se que lactentes em uso de fórmulas infantis especializadas necessitam de reavaliações periódicas, visando verificar a evolução do quadro clínico e a necessidade da permanência ou alteração da terapia nutricional inicialmente proposta. Neste contexto, sugere-se previsão do período de uso ou delimitação das reavaliações clínicas.*

9. *Cumpra informar que fórmulas infantis à base de aminoácidos livres possuem registro ativo na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).*

10. *Quanto à disponibilização de FAA no âmbito do SUS, cumpra informar que:* • *As fórmulas especializadas para o manejo da APLV foram incorporadas, conforme Portaria SCITIE/MS nº 67, de 23 de novembro de 2018, para crianças de 0 a 24 meses com alergia à proteína do leite de vaca (APLV) no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS¹³. Porém, ainda não são dispensadas no SUS de forma administrativa;*

• Ressalta-se que atualmente existe o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para Alergia à Proteína do Leite de Vaca, elaborado em abril de 2022, atualmente em fase de encaminhamento para publicação^{6,14}. Com isso, não é possível apontar se o item pleiteado será disponibilizado e quais serão os critérios de acesso;

• No Município do Rio de Janeiro existe o Programa de Assistência à Criança Portadora de Diarreia Persistente (PRODIAPE), onde podem ser fornecidas fórmulas especializadas (à base de proteína do leite extensamente hidrolisada, à base de proteína isolada de soja, ou à base de aminoácidos livres), para lactentes com diagnóstico de APLV, até completarem 2 anos de idade. A unidade de saúde a qual pertence o Programa é o Hospital Municipal Jesus (HMJ) vinculado a SMS/RJ (Rua Oito de Dezembro, 717, Vila Isabel)¹⁵; • Contudo, em documento da Câmara de Resolução de Litígios em Saúde, consta a seguinte informação: "... Fomos comunicados pelo NIR da CAP que a oferta do procedimento CONSULTA EM PEDIATRIA LEITES ESPECIAS no HMJ foi encerrada no SISREG não havendo mais vagas disponíveis para o PRODIAPE ...".

11. Dessa forma, entende-se que a via administrativa não oferta acesso ao item pleiteado.

12. Quanto à consulta em gastropediatria, informa-se que está indicada ao manejo da condição clínica do Autor - história de intolerância à caseína, episódios diarreicos,

Ante o exposto, voto por **CONHECER** dos recurso e **DAR-LHE** provimento para, na forma do art. 300 do CPC, para **para determinar que os réus, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, forneçam à parte autora o fármaco infantil à base de proteína hidrolisada**, nos termos da prescrição médica juntada em Evento 1, ANEXO2, pág.16. Dirciono à **UNIÃO** o cumprimento da referida obrigação, por se tratar de medicamento não padronizado pelo SUS no âmbito do SMS/RJ, resguardada a possibilidade de ressarcimento em desfavor dos demais entes réus, ante a responsabilidade solidária das entidades federativas no presente caso. Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juízo de origem.